Pacient 8 r. č. 823456/8888 poj.

tel.

Propouštěcí zpráva

Hospitalizace: (6 dní)

OA: HTN, DM II. na PAD, chron VAS L páteře, Hypothyreoza, progresivní polyartritida, stp op tumoru tlustého střeva 1999, stp borelioze

FA: Betaloc 200mg 1-0-0, Lozap H 1-0-0, Euthyrox 112ug 1-0-0, Purinol 300mg 01-0-, Omeprazol 20 mg 1-0-0, Mertenil 20 mg 0-0-1, Metformin 500mg p.o. 1-0-0, Zaldiar dlp

GA: pravidelně sledována

Abusus: nekuřák,abstinent

ALERGIE: neguje

Nynější onemocnění:

Pacientka s tumorem prsu vlevo.
V rámci MASC záchyt drobného okrskovitého stínu **na rozhraní DKK** při bazi žlázy vlevo, sonograficky oválné ložisko **8x3mm** v blízkosti submamární rýhy.
stp CCB Imunohistochemické vyšetření:
E-CAD (DAKO, klon NCH-38).....negativní
Ki67 (Zytomed, klon SP6).....10 %
ER (Novocastra, klon 6F11/2).....100 %
PR (Novocastra, klon 312/2).....0
Her2neu (Ventana, klon 4B5)..... HER2 negativní (skóre 0)
M1: M85203 KARCINOM LOBULARNI INFILTRUJICI

Předvedena na mamologickém MDT - **Indikován prs záchovný výkon vlevo + SLNB. Ložisko bude značeno Magseed zrnem.**

Status praesens:

lucidní, orientovaný, hydratovaný, aniktерický, přiměřené výživy HLAVA: poklepově nebolestivá, zornice isokorické, sklery aniktерické, jazyk plazí středem, nepovleklý. KRK: thyroidea a nodi 1.nezv., pulsace karotid symetrická, náplň žil nezv. HRUDNÍK: fysiologicky klenutý, srdce pravidelné akce bvf., plíce sklípkového dýchání bvf. BŘICHO: v niv., dýchá v celém rozsahu, měkké, volně prohmatné, nebolestivé, bez zjevné patol. rezistence, bez známek peritoneálního dráždění, poklep diferencovaný, nebolestivý, peristaltika normokinetická, bez známek odporu, hepar+lien 0, tptt. bil. neg., per rectum negat. nález. HKK: fysiol. nález. DKK: bez otoků a varixů, pulsace hmatné do periferie.

Status localis:

rány klidné, primárně hojeny, vstřebatelným stehem, bez retence či zarudnutí, neurocirkulační poměry v normě,

Operace:

02.04.2026 - BCS - lumpectomia (MAGSEED, MOZART) + SLNB axillae l.sin. (GAMASONDA), RD NoII(duas)

Přehled terapie:

AZEPO, INJ/INF PLV SOL, 1G; AGEN, TBL NOB, 5MG; BETALOC SR, TBL PRO, 200MG; EUTHYROX, TBL NOB, 112MCG; LOZAP H, TBL FLM, 50MG/12,5MG; MERTENIL, TBL FLM, 20MG; METFORMIN ACCORD, TBL FLM, 500MG; OMEPRAZOL MEDREG, CPS ETD, 20MG; PURINOL, TBL NOB, 300MG; ZALDIAR, TBL FLM, 37,5 MG/325MG; GRANDAXIN, TBL NOB, 50MG; FRAXIPARINE, INJ SOL ISP, 9500IU/ML

UPV: Ne

Průběh hospitalizace:

pacientka karcinomem prsu byla přijata plánovaně a po předoperační přípravě indikována k výkonu v celkové anestezii: 02.04.2026 - BCS - lumpectomia (MAGSEED, MOZART) + SLNB axillae l.sin. (GAMASONDA), RD NoII (duas). Po výkonu kardiopulmonálně stabilní, afebrilní, neurocirkulační poměry v normě, rány klidné, bez zarudnutí či retence, dreny s klesající sekrecí odstraněny, vertikalizována, subjektivně se cítí dobře, propouštíme do ambulantní péče.

Diagnostický souhrn:

Ca mammae lobullare l.sin DKK 8x3 mm
Hypertenze ess
DM T2 na PAD
Chron VAS L páteře
Hypothyreoza na substituci
Progresivní polyartritida
Stp op tumoru tlustého střeva 1999+CHT

Propouštěcí zpráva - pokračování

Stp borelioze

Diagnózy:

C509 ZN - prs NS
I10 Esenciální (primární) hypertenze
E038 Jiná určená hypotyreóza
E119 Diabetes mellitus 2. typu bez komplikací

Doporučení:

klidový pooperační režim, rány udržovat v čistotě, možno sprchovat, po týdnu odlepit omnistrip a lze krémovat jakýmkoliv kremem.

Kontrola u praktického lékaře do 3 dnů od propuštění s propouštěcí zprávou.

Kontrola v mamologické ambulanci doktora. poliklinika při obtížích možná kontrola dříve ve všeobecné chirurgické ambulanci Akutního příjmu .

Doporučená medikace:

MERTENIL, TBL FLM, 20MG, p.o., 0-0-1;PURINOL, TBL NOB, 300MG, p.o., 0-1-0;ZALDIAR, TBL FLM, 37,5 MG/325MG, p.o., 1-1-1;BETALOC SR, TBL PRO, 200MG, p.o., 1-0-0;LOZAP H, TBL FLM, 50MG/12,5MG, p.o., 1-0-0;EUTHYROX, TBL NOB, 112MCG, p.o., 1-0-0;OMEPRAZOL MEDREG, CPS ETD, 20MG, p.o., 1-0-0; METFORMIN ACCORD, TBL FLM, 500MG, p.o., 0-0-1, běžná analgetizace dle potřeby